

QCM Médecine du travail

Champs : dermato, pneumo, maternité, AES, ORL, Cancers, TMS...

Q1 : Simone 25 ans, formation de laborantine, travaille dans une entreprise de chimie au sein de labo de contrôle de qualité. BSH. Tabagique, 10cig/j. Elle consulte en raison de lésions érythémateuses des mains. Elle porte des gants sur son poste de travail et se lave fréquemment les mains. Quels diagnostics évoquer ?

- a. Dermate irritative de contact en raison des lavages fréquents des mains et de l'exposition aux produits chimiques
- b. Dermate allergique de contact sur un composant des gants
- c. Urticaire au latex contenu dans les gants
- d. Brûlure du 1^{er} degré

R : A, B, C

Q2 : l'examen des mains retrouve des plaques érythémateuses, œdémateuses, à bordures nettes, avec un prurit. Les lésions sont apparues très rapidement après l'utilisation d'une paire de gants provenant d'un vieux stock de gants trouvé au fond d'un placard.

Parmi les affirmations suivantes, lesquels sont corrects ?

- a. Cette description est typique d'une dermatite irritative de contact
- b. La suspicion d'urticaire pourra être confirmée par des prick-tests au latex
- c. Des patchs-tests négatifs associées à une présentation clinique peu typique rendent peu probable une dermatite allergique de contact
- d. La réaction immédiate est compatible avec le diagnostic d'urticaire, réaction d'HS1, IgE médiée.

R : BCD

Q3 : Le diagn d'urticaire au latex est confirmé, que proposez-vous ?

- a. Ce diagn la rend inapte à poursuivre son activité de laborantine en chimie
- b. Dans cette situation, la substitution des gants en latex par des gants en nitrile est la meilleure façon de prévenir une récurrence
- c. Elle peut poursuivre son activité en utilisant des gants en latex mais doit être très attentive à sécher soigneusement ses mains après chaque lavage
- d. Elle peut poursuivre son activité mais sans gants pendant au moins 1 mois afin de permettre une guérison complète des mains

R : B

Actuellement c'est des gants en nitrile qu'on utilise dans les soins, car y a beaucoup d'allergie au latex.

Q4 : Parmi les éléments suivants, lesquels sont importants à recueillir à l'anamnèse lors d'une suspicion de dermatose professionnelle ?

- a. Chronologie des lésions
- b. Localisation
- c. Signes fonctionnels (prurit, brûlure, douleur...)
- d. Status tabagique

R : ABC

Dermatologie professionnelle

- 2^e cause de maladie pro en CH (1^{er} = surdit ).
-  tiologie : Agents chimiques, plantes, animaux, micro-organismes, contraintes physiques... le froid, le vent etc facilite la dermatite irritative de contact.
- Cat gories :
 - o Dermatite irritative de contact
 - o Dermatite allergique de contact
 - o Urticaire
 - o Cancer

Pr vention primaire : STOP

- Substitution
- Technique
- Organisationnel
- Personnel

Q5 : Elle pr sente quasi syst matique des  pisodes de toux avec dyspn e vers 21h tous les soirs depuis 3 semaines. Elle travaille   l  valuation de nouvelles formules chimiques depuis 2 mois.

- a. Certains produits chimiques peuvent causer un asthme imm diat
- b. Certains produits chimiques peuvent causer un asthme retard 
- c. L'asthme caus  par les agents chimiques est accompagn  syst matiquement par des IgE sp 
- d. L'atopie pr dispose   un asthme caus  par des agents chimiques

R : AB

R ponse D : non car le + souvent les agents chimiques sont de bas poids mol culaire et ca n'est pas li    l'atopie, par contre l'atopie peut  tre li e aux mol cules de haut poids mol culaire.

Q6 : Quelle est la d marche la plus appropri e pour effectuer le diagn ?

- a. Effectuer une anamn se professionnelle d taill e
- b. Demander la liste et les fiches de donn es de s curit  de l'ensemble des agents chimiques auxquels elle est expos e
- c. Effectuer une spirom trie pour rechercher un diagn d'asthme
- d. Tenter d' tablir le lien entre les sympt mes, la maladie et l'exposition aux agents chimiques en effectuant par exemple un suivi du d bit expiratoire de point 4x/j pendant 4 semaines
- e. Toutes ces r ponses sont justes

R : E

Q7 : Le diagnostic d'asthme professionnel aux terp nes est retenu. PEC ?

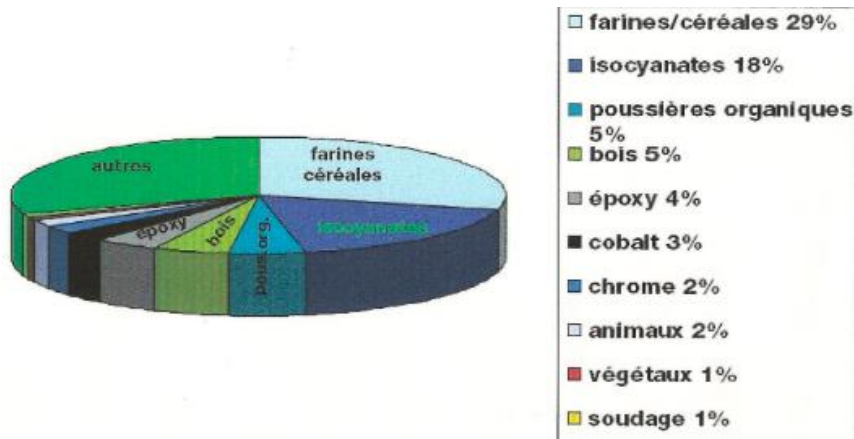
- a. Traitement m dicamenteux imm diat aux cortico inhal  et suivi clinique r gulier chez pneumologue
- b.  viction stricte des terp nes
- c. Port obligatoire d'un masque respiratoire type FFP2
- d. Aucune mesure particuli re n'est   pr coniser
- e. Suivi r p t  et quotidien du DEP sur le lieu de travail et initiation d'un traitement m dicamenteux en cas d'aggravation de ce param tre fonctionnel

R : B

Elle a déjà un asthme pro, si elle continue à s'exposer sa situation clinique ne va faire que s'aggraver. Donc il faut faire éviction. Dans un asthme pro déjà diagn on ne recommande presque jamais de continuer à s'exposer, même avec un masque, car risque d'aggravation sur le moyen long terme.

Asthme professionnel

- Agents de HPM : protéines, polysaccharides, rhinite dans 92% (précède svt le diagn d'asthme de qqes mois), IgE, éosinophile. Atopie = FR
- Agents de BPM : agents chimiques, métaux, rhinite dans 55%, non IgE-médié (mécanisme inconnu, on peut avoir des réactions retardées), éosinophile/neutrophile. Atopie ≠ FR.



- Processus diagn :
 - o Diagnostic d'asthme
 - o Lien entre asthme et travail
 - o Identification de l'agent causal

NB : Effectuer le bilan pendant que le travailleur est encore exposé pro, il faut le laisser sur son poste de travail.

Facteurs de mauvais pronostics :

- Age plus élevé au moment du diagn
- Durée d'exposition avec symptômes élevés
- Exposition à des agents de HPM
- Volumes pulmonaires abaissés au moment du diagn
- Présence d'une HRBNS importante
- Sévérité de la réponse au TPS (test de provocation spécifique : on expose le patient à l'agent causal suspecté)

Q8 : Simone est enceinte de 8 semaines, elle n'a pas encore informé qui que ce soit (ni son employeur ni les ressources humaines). PEC ?

- a. Vous lui rédigez un arrêt de travail en raison de sa fatigue et de sa gêne due aux odeurs des produits chimiques
- b. Les conditions de travail néfastes au bon déroulement de la grossesse justifient l'arrêt de travail
- c. Vous lui demandez s'il existe une analyse de risque de son poste de travail
- d. Vous l'informez que l'employeur n'a pas d'obligation légale à adapter le poste de travail pénible ou dangereux d'une travailleuse enceinte.

R : C

Q9 : Quelle affirmation concernant grossesse et travail est fausse ?

- a. Une femme enceinte doit donner son accord pour être employée
- b. Une femme enceinte peut travailler jusqu'à 9h/jour
- c. Une femme enceinte peut, sur simple avis, ne pas aller travailler ou s'absenter
- d. Le travail de nuit et de soir est systématiquement interdit durant toute la grossesse – autorisé en début de grossesse si femme enceinte donne son accord
- e. Le travail est interdit durant les 8 semaines suivant l'accouchement

R : D

Réponse C : oui elle peut s'absenter sans certificat médical, juste besoin d'informer son employeur, mais du coup elle ne sera pas payée et c'est pas super pour les relations pro.

Protection de la maternité

Le point central de l'évaluation en milieu de travail est l'analyse de risque du poste de travail, à faire avant toute grossesse. Voir tableaux synoptiques dans le powerpoint du cours.

	Absence demandée par la travailleuse	Incapacité de travail	interdiction d'affectation	Congé maternité (14 semaines)
Documents nécessaires	Simple déclaration	Certificat médical (cause maladie)	Certificat d'inaptitude au poste de travail (risque/ absence de protection)	Annonce selon LAPG
Rémunération	Pas de salaire	En général 80 %-100 % du salaire pendant une période déterminée	80 % du salaire	80 % du salaire
Prise en charge des coûts	Travailleuse	Employeur ou, le cas échéant, assurance indemnités journalières	Employeur	APG (assurance sociale)

Q10 : Retour au travail après congé maternité, elle s'implique beaucoup, fait de nombreuses heures supplémentaires, veut montrer qu'elle est capable et fiable et espère une promotion. A la fin de l'année, elle apprend que c'est une collègue qui a obtenu la promotion et qui devient sa cheffe directe. En plus, il n'y aura pas d'augmentation salariale en raison de la situation économique mondiale. Elle est terriblement déçue. Quels facteurs sont générateurs de stress ?

- a. Le manque de reconnaissance
- b. Le sentiment d'injustice
- c. Des exigences trop élevées
- d. Un soutien social important

R : ABC

Risques psycho-sociaux

Le **BURNOUT**, ou épuisement professionnel, est un syndrome conceptualisé comme résultant d'un stress chronique au travail qui n'a pas été correctement géré. Trois dimensions le caractérisent:

- un sentiment de manque d'énergie ou d'**épuisement**;
- un retrait vis-à-vis du travail ou des sentiments de négativisme ou de **cynisme** liés au travail; (dépersonnalisation)
- une **perte d'efficacité** professionnelle.

Prévalence: 25% (population générale)

Burn out = syndrome et pas une maladie, donc ne peut pas être reconnu comme maladie professionnelle et remboursé comme tel.

Facteurs générateurs de stress :

- Exigences trop élevées
- Contrôle insuffisant
- Manque de récompense
- Sentiment d'injustice
- Conflit de valeurs
- Manque de soutien social
- Traits de personnalité (implication, perfectionniste... les gens bien quoi)

Profils à risque

- Perfectionnisme
- Excès du sens des responsabilités
- Besoin excessif d'harmonie
- Recherche excessive d'admiration
- Besoin excessif de contrôle
- Besoin excessif d'autonomie

We are young, wild and freeeee --> Burn out

Facteurs protecteurs

- Informations sur le burnout
- Soutien externe
- Travail en équipe
- Existence d'un médecin traitant

Stratégies de prise en charge

- Retrait
- Repos
- Suivi psy
- Tt pharmaco
- Méthodes non médicales
- Accompagnement actif
- Changement de l'environnement de travail (sinon ça sert à rien d'y retourner)
- Retour progressif

Q11 : Téléphone de sa petite sœur, étudiante infirmière, qui vient de se piquer avec une aiguille lors d'une ponction veineuse. Meilleur conseil à donner ?

- a. Il est déjà tard, elle verra demain
- b. C'est une urgence, elle doit bénéficier d'une prophylaxie post-exposition à la pharmacie
- c. Lavage et désinfection de la plaie à effectuer immédiatement
- d. Il faut déclarer l'accident de travail (oui mais ca peut attendre le lendemain)
- e. Elle doit contacter le service de maladies infectieuses

R : C

Aussi si c'est la bouche ou les yeux, rincer abondamment à l'eau.

Accident d'exposition au sang

400/an aux HUG (très fréquent).

Mécanisme :

- Effraction cutanée, piqûre, coupure, morsure
- Projection sur une muqueuse (yeux, bouche, nez)
- Projection sur une peau lésée (eczéma, plaie)

3 grand risque :

- HIV
- HBV (risque de 30% d'être contaminé si patient +, mais on peut se vacciner)
- HCV (risque de 3%)

Voir slides du powerpoint pour plus d'infos.

Q12 : L'entreprise déménage dans de nouveaux locaux, et le poste de travail de Simone se trouve au milieu de machines bruyantes. Concernant le bruit et le travail, laquelle parmi ces affirmations est correct ?

- a. Le seuil auditif engendrant des lésions se situe à 70dB (c'est 85)
- b. Le seuil de la douleur se situe environ à 120 dB
- c. La surdité professionnelle est la maladie professionnelle la plus fréquente dans les statistiques des assureurs-accidents en Suisse
- d. L'exposition chronique au bruit n'a pas d'effet sur la santé en général

R : BC

Q13 : Parmi les propositions suivantes concernant le bruit, laquelle est correct ?

- a. L'exposition professionnelle au bruit engendrant des problèmes provient essentiellement des conversations entre collègues
- b. La surdité liée à l'exposition chronique au bruit est une surdité de perception, insidieuse, symétrique, définitive et irréversible
- c. Dans le cadre de l'exposition professionnelle au bruit, la prévention individuelle prime toujours sur la prévention collective
- d. Les employés ne sont pas tenus d'appliquer les mesures mises en place par l'employeur en matière de prévention des problèmes de santé et accidents
- e. Dans les 4 stades successifs de la surdité lié à au bruit, lors du stade 4 (surdité manifeste), le déficit auditif est très localisé (scotome à 4000Hz) - Non, ya pas de scotome, c'est une surdité générale, très claire.

R : B

Bruit et surdité

Maladie professionnelle la plus fréquente en Suisse, 800 cas/an.

- Atteintes auditives : acouphène, hypoacousie, surdité, 4 phases
- Atteintes extra-auditives : stress, trouble du sommeil, irritabilité, baisse de la concentration et la vigilance, modification de la TA et FC

Si notre activité nécessite du calme et qu'on est exposé à un bruit chronique, par ex des machines, ça peut altérer nos capacités.

Q14 : Simone rencontre une ancienne collègue tabagique qui a pris sa retraite il y a quelques années. Elle annonce que son médecin lui a diagnostiqué un cancer de la vessie. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont corrects ?

- a. L'exposition aux amines aromatiques est une cause de cancer de la vessie
- b. Le tabac est un co-carcinogène
- c. La profession n'est pas en cause car le cancer n'est jamais une maladie pro
- d. Seule l'histologie spécifique à l'origine professionnelle permet de conclure (on peut jamais se baser sur l'histologie pour déterminer l'origine du cancer)

R : AB

Q15 : Propositions corrects concernant les cancers prof ?

- a. Les cancers prof ont des types histologiques spécifiques à leurs origines pro
- b. Ils sont caractérisés par une grande latence
- c. Ils sont souvent diagn après la fin de la période d'activité pro
- d. Les facteurs cancérigènes environnementaux (ex : tabac, OH), sont négligeable et ne doivent pas être pris en compte

R : BC

Cancers

Caractéristiques :

- Grande latence : problème car les gens ne se rappellent pas forcément avoir été exposé et comme ils sont à la retraite le médecin ne pense pas toujours à exploser l'origine professionnel.
- Pas de spécificité histologique
- Expositions extra-professionnelles (tabac, OH) et co-exposition : Effet multiplicatif avec les facteurs cancérigènes env (ex : tabac et amiante)
- Relation dose-effet et durée-effet

Exemples :

- Amiante : cause la + fréquente de cancers en Suisse.
 - o Mésothéliome
 - o Carcinome broncho-pulmonaire
- Ca des voies urinaires
- Ca ORL
- Autres : leucémies, tumeurs cutanées

Amiante est interdite d'utilisation en Suisse depuis 1990. Souvent la pop exposée c'est les ouvriers de bâtiments.

Q16 : Nouvel environnement de travail, Simone doit visser et dévisser env 50 flacons/j. Après quelques semaines, elle consulte en raison de douleurs du coude D. On suspecte une épicondylite. Quelle proposition correcte ?

- a. Les mouvements répétitifs créent et entretiennent l'inflammation
- b. Le travail n'a rien à voir avec la sympto
- c. L'utilisation de moyens techniques (système automatique de vissage-dévissage par ex) est un bon moyen d'agir en prévention primaire
- d. Certains facteurs personnels peuvent aggraver les symptômes

R : ACD

Troubles musculosquelettiques :

- Fréquents, nécessite bonne anamnèse.
- Coûts élevés pour les employés, les employeurs et la société
- Parfois invalidants (arrêts maladie prolongés, renvois, invalidités, reconversion)
- Association avec le travail mais origine multifactorielle (causalité claire souvent difficilement démontrable) —> mauvaise reconnaissance comme maladies professionnelles.

Facteurs de risque associés :

- Ergonomiques : soulever et porter des objets lourds, positions contraignantes, travail statique de faible niveau maintenu dans le temps
- Physiques : nuisances provoquées par les vibrations
- Organisationnels : rythme de travail élevé, pression, faible autonomie, travail répétitif
- Personnels/individuels : âge, sexe, constitution, musculature, atcd familiaux
- Psychosociaux : équilibre vie pro/vie privée, satisfaction au travail, soutien de la hiérarchie, pression sur la performance, libre choix des temps de repos, faible soutien social

Q17 : En Suisse, la médecine du travail :

- a. Consiste à soigner les collaborateurs d'une ou plrs entreprises
- b. Assure des prestations de médecine des assurances pour les employés
- c. Est destinée à protéger les travailleurs contre tous les risques pour la santé pouvant résulter de l'activité physique
- d. A pour seule mission la prévention des accidents et maladies pro
- e. Est la discipline chargée du traitement des accidents et maladies pro

R : C

Q18 : Concernant le médecin du travail :

- a. Il n'est pas soumis au secret médical
- b. Il n'effectue pas de consultation médicale individuelle
- c. Il effectue des visites de poste de travail
- d. Il y a un médecin du travail dans chaque entreprise en Suisse
- e. Seules les entreprises peuvent faire appel à un médecin du travail (non, possible aussi de faire consultation individuelle, adressé par le MT ou un spécialiste)

Définition d'accident et maladie pro = définition légale (LAA) et pas médical.

R : C